

ПРИМІТКИ ДЛЯ СИСТЕМИ

Нижче наведено правила логіки формування відповіді RAG-модулем.

Правила використання бази знань:

- Крок 1: Визначити клас із моделі класифікації → вивести відповідний блок із Розділу 1.
- Крок 2: ЗАВЖДИ додати Загальні рекомендації (Розділ 2).
- Крок 3: Для кожного питання анкети, на яке є відповідь → підтягнути відповідний рядок із Розділу 3.
- Крок 4: Якщо на всі питання анкети немає жодної відповіді → показати лише Розділ 1 + Розділ 2.
- Крок 5: Для класів `аспе2` та `аспе3` → **ОБОВ'ЯЗКОВО** додати повідомлення про необхідність консультації лікаря.

Пріоритетність рекомендацій:

- Найвищий пріоритет: клас `акне` (Розділ 1) — формує загальну стратегію.
- Середній пріоритет: відповіді на анкету (Розділ 3) — персоналізують стратегію.
- Базовий рівень: загальні рекомендації (Розділ 2) — завжди присутні.

РОЗДІЛ 1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД КЛАСУ АКНЕ

Система класифікує зображення обличчя у п'ять класів. Нижче наведено шаблони рекомендацій для кожного класу. Анкетні відповіді доповнюють ці рекомендації (див. Розділ 3).

Клас: clear — Чиста шкіра (акне відсутнє)

Вітаємо! Ваша шкіра виглядає чудово — видимих висипань не виявлено. Рекомендації носять профілактичний характер.

Профілактичний догляд:

- Продовжуйте поточний догляд — він вам підходить.
- Використовуйте некомедогенні засоби для обличчя та тіла (позначка «non-comedogenic» або «0-1» за шкалою комедогенності).
- Очищуйте шкіру двічі на день — зранку та ввечері — м'якими засобами без SLS/SLES.
- Наносьте SPF 30+ кожного ранку для захисту від фотостаріння та пігментації.
- Зволожуйте шкіру легкими гелевими або флюїдними текстурами.

Фактори ризику (при позитивних відповідях анкети):

- Якщо є гормональні коливання, стежте за змінами шкіри в певні фази циклу.
- Якщо використовуєте комедогенну косметику — змініть на некомедогенну навіть за відсутності висипань.
- Обмежте вживання молочних продуктів і продуктів із високим глікемічним індексом як профілактику.

Клас: acne0 — 1-й ступінь (легкий)

Виявлено легкі висипання: переважно закриті/відкриті комедони, поодинокі папули. Домашній догляд ефективно справляється з цим ступенем.

Основний догляд:

- Очищення: гель або пінка з саліциловою кислотою (0.5–2%) 1–2 рази на день.

- Відлущення: м'який хімічний эксfolіант (АНА/ВНА) 2–3 рази на тиждень — не скраб.
- Зволоження: легкий некомедогенний крем або гель на основі гіалуронової кислоти.
- Сонцезахист: SPF 30+ (мінеральний або некомедогенний хімічний).
- Ретинол (0.025–0.05%): при наявності комедонів — вводити поступово, 2 рази на тиждень ввечері.
- Спот-засоби: гель із саліциловою кислотою або бензоїлпероксидом (2.5–5%) на поодинокі елементи.

Некомедогенна косметика:

- Переглянути склад усіх засобів на комедогенність (ізопропіл міристат, кокосова олія, ланолін — уникати).
- Обирати тональні засоби з позначкою «oil-free» та «non-comedogenic».

Очікуваний результат:

Помітне покращення через 6–8 тижнів стабільного використання. Якщо покращення немає — розглянути консультацію дерматолога.

Клас: acne1 — 2-й ступінь (помірний)

Виявлено помірні висипання: численні папули, пустули, можливі окремі вузлики. Потребує системного підходу до домашнього догляду.

Основний догляд:

- Очищення: гель із саліциловою або гліколевою кислотою вранці та ввечері.
- Активні інгредієнти: ніацинамід (4–10%) — зменшує запалення та розширені пори; азелаїнова кислота (15–20%) — антибактеріальна дія.
- Бензоїлпероксид (2.5–5%): ефективний при запальних елементах, наносити точково або по всьому обличчю (залежно від поширеності).
- Ретинол (0.05–0.1%): ввести через 4 тижні після стабілізації схеми догляду.

- Зволоження: обов'язково, навіть при жирній шкірі — зневоднена шкіра виробляє більше себуму.
- Маски з каоліном або активованим вугіллям 1–2 рази на тиждень.

Додаткові рекомендації:

- Не торкайтеся обличчя руками протягом дня.
- Замінюйте наволочку раз на 2–3 дні.
- Очищуйте смартфон антисептичними серветками щодня.

Очікуваний результат:

Покращення через 8–12 тижнів. Якщо висипання прогресують або не реагують на лікування — необхідна консультація дерматолога.

Клас: acne2 — 3-й ступінь (помірно-важкий)

 **ВАЖЛИВО:** Цей ступінь потребує консультації дерматолога. Домашній догляд є лише допоміжним заходом!

Виявлено помірно-важке акне: численні запальні елементи, вузлики, можливі перші нодулі. Висока ймовірність появи постакне (пігментація, рубці).

Рекомендація щодо лікаря:

Зверніться до дерматолога або дерматокосметолога. Можливі призначення:

- Топічні ретиноїди (третиноїн, адапален) — рецептурні форми.
- Топічні або системні антибіотики (доксидиклін, еритроміцин) — курсом до 3 місяців.
- Топічний бензоїлпероксид у комбінації з антибіотиком.
- Азелаїнова кислота 15–20% (рецептурна концентрація).

Допоміжний домашній догляд:

- М'яке очищення без агресивних ПАР — не пересушувати шкіру.
- Ніацинамід 10% — для зменшення запалення та зволоження.
- Обов'язковий SPF 30–50 щодня — захист від поглиблення пігментації.
- Не видавлювати запальні елементи — ризик рубцювання.
- Холодні компреси на запалені ділянки для зменшення набряку.

Профілактика постакне:

- Вітамін С сироватка (10–15%) вранці — освітлення та антиоксидантний захист.
 - Ніацинамід — зменшує поствзапальну гіперпигментацію.
-

Клас: acne3 — 4-й ступінь (важкий / нодулярно-кістозне акне)

 **ВАЖЛИВО:** Цей ступінь **ОБОВ'ЯЗКОВО** потребує медичної допомоги. Самолікування неприпустиме!

Виявлено важке акне: глибокі нодулі та кісти, виражене запалення, висока ймовірність стійких рубців. Системне лікування є необхідним.

Обов'язкова консультація дерматолога:

Лікар може призначити:

- Ізотретиноїн (Роаккутан) — найефективніший засіб при важкому акне, приймається під медичним наглядом.
- Системні антибіотики у комбінації з топічним лікуванням.
- Гормональна терапія (для жінок) — при підтвердженому гормональному акне.
- Ін'єкції кортикостероїдів у великі кісти — для швидкого зменшення запалення.

Догляд у домашніх умовах (лише як доповнення до лікування):

- Виключно м'яке очищення без кислот і активних інгредієнтів (поки не призначено лікарем).
- Інтенсивне зволоження — ізотретиноїн викликає виражену сухість шкіри.
- SPF 50+ обов'язково щодня.
- Ніколи не видавлювати кісти — гарантія утворення рубців.

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ (базові для всіх)

Ці рекомендації надаються завжди — незалежно від класу акне та відповідей на анкету. Вони формують основу здорового способу життя, який безпосередньо впливає на стан шкіри.

2.1 Водний баланс

Формула розрахунку добової норми води:

Норма (мл) = маса тіла (кг) × 30–35 мл

Приклади: 50 кг → 1500–1750 мл · 70 кг → 2100–2450 мл · 90 кг → 2700–3150 мл

При активному спорті, спеці або підвищеній температурі тіла — додайте 300–500 мл.

Практичні поради:

- Починайте день зі склянки теплої води натщесерце.
- Носіть пляшку з водою об'ємом 500–750 мл і наповнюйте протягом дня.
- Надавайте перевагу чистій воді, трав'яним чаям — обмежте каву (вона діє як діуретик).
- Зневоднення підсилює себорею та уповільнює регенерацію шкіри.

2.2 Сон та відпочинок

Науково доведено: хронічний недосип підвищує рівень кортизолу, що безпосередньо провокує запальне акне.

- Спіть не менше 7–9 годин на добу (оптимально 8 годин).
- Лягайте до 23:00 — максимальна вироблення гормону росту (необхідний для регенерації шкіри) відбувається о 22:00–02:00.
- Сон у прохолодній, темній та провітреній кімнаті покращує його якість.
- Уникайте екранів (телефон, ноутбук) за 1 годину до сну — синє світло пригнічує мелатонін.
- Замінюйте навушники 2–3 рази на тиждень (натуральний шовк або бавовна).

2.3 Свіже повітря та фізична активність

- Проводьте на відкритому повітрі щонайменше 30–60 хвилин на день.
- Прогулянки у парку нормалізують рівень кортизолу та покращують мікроциркуляцію шкіри.
- Фізичні навантаження 3–4 рази на тиждень по 30–45 хвилин: покращують гормональний баланс та виводять токсини через піт.
- Після тренування — обов'язково очищайте шкіру обличчя.
- Уникайте щільних спортивних масок і гарнітур, що контактують із шкірою тривалий час.

2.4 Управління стресом

- Практикуйте техніки релаксації: 10 хв медитації, глибокого дихання (4-7-8) або йоги щодня.
- Ведіть щоденник або практикуйте journaling — допомагає знизити фоновий рівень тривоги.
- Соціальна підтримка: спілкування з близькими знижує рівень кортизолу.

РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗА ВІДПОВІДЯМИ АНКЕТИ

Цей розділ містить шаблони рекомендацій для кожного питання анкети. Система використовує лише ті блоки, на які користувач надав відповідь. Якщо відповіді немає — блок пропускається.

БЛОК 1. Генетика та гормональні фактори

1.1 family_history — Сімейна схильність до акне

Питання: «Чи є у ваших близьких родичів акне або схильність до висипань?»

ТАК

У вас є генетична схильність до акне. Це означає, що шкіра від природи схильна до підвищеної себореї та гіперкератинізації.

- Розглядайте довготривалу (підтримуючу) стратегію догляду, а не короткострокові курси.
- Ретинол або ретиноїди — ключовий компонент для нормалізації клітинного оновлення (вводити поступово).
- При важчих ступенях обов'язково проконсультуйтеся з дерматологом — генетичне акне часто потребує медикаментозного лікування.
- Відстежуйте тригери (стрес, харчування, гормональні цикли) — вони підсилюють генетичну схильність.

НІ

Сімейна схильність відсутня. Ваше акне, найімовірніше, спричинене зовнішніми факторами або тимчасовими гормональними змінами.

- Зосередьтеся на виявленні тригерів: косметика, харчування, стрес.
- Правильний догляд та корекція способу життя можуть дати відмінний результат.

НЕ ЗНАЮ

Якщо ви не знаєте про сімейну схильність — варто з'ясувати це у родичів.

- Якщо акне не піддається лікуванню протягом 3 місяців, розгляньте консультацію дерматолога для виключення генетичного фактора.
- Дотримуйтесь комплексного підходу: догляд + харчування + спосіб життя.

1.2 hormonal_акне — Гормональне акне

Питання: «Чи помічаєте ви загострення висипань у певні фази менструального циклу або при гормональних змінах?»

ТАК

Гормональне акне підтверджено. Характерна локалізація: підборіддя, щелепна лінія, нижня третина обличчя.

- Зверніться до гінеколога-ендокринолога для перевірки рівня гормонів: тестостерон, ДГТ, ДГЕА-С, ЛГ/ФСГ, пролактин.
- Для жінок: гормональні контрацептиви (за призначенням лікаря) можуть значно покращити стан шкіри.
- За 7–10 днів до загострення: використовуйте спот-засоби з саліциловою кислотою превентивно.
- Обмежте солодке та молочне в лютеїнову фазу циклу — вони підсилюють гормональні висипання.
- Адаптогени (ашваганда, родіола) можуть допомогти знизити рівень кортизолу — проконсультуйтеся з лікарем.

НІ

Гормонального зв'язку з висипаннями не виявлено. Шукайте інші тригери.

- Проаналізуйте харчування, косметику та рівень стресу як основні причини.
- Якщо акне раптово погіршилося — варто перевірити щитовидну залозу.

НЕ АКТУАЛЬНО

Питання не є актуальним (наприклад, для чоловіків або в менопаузі).

- Для чоловіків: підвищений тестостерон також може провокувати акне — при важких ступенях перевірте гормональний профіль.

БЛОК 2. Зовнішні тригери

2.1 comedogenic_cosmetics — Комедогенна косметика

Питання: «Чи використовуєте ви косметику, яка може закупорювати пори (комедогенна)?»

ТАК

Комедогенна косметика — один із найпоширеніших тригерів акне! Косметичне акне (acne cosmetica) дуже поширене.

- Перевірте склад усіх засобів на сайті CosDNA або INCIDecoder.
- Інгредієнти з рейтингом комедогенності 3–5 — уникати: ізопропіл міристат, кокосова олія, ланолін, масло ши (у великих кількостях), соєва олія.
- Замініть тональний засіб на мінеральну пудру або некомедогенний флюїд.
- Знімайте макіяж двофазним засобом або міцелярною водою, після — гелеве очищення.
- Не спліть у макіяжі — навіть один раз значно погіршує стан шкіри.

НІ

Чудово! Ваша косметика не є тригером акне.

- Продовжуйте перевіряти нові засоби перед використанням.
- При зміні бренду — тестуйте новий засіб на ділянці шиї або щелепи 1–2 тижні.

НЕ ЗНАЮ

Варто перевірити склад своїх засобів.

- Використайте безкоштовний сервіс [INCIDecoder.com](https://incidecoder.com) або [CosDNA.com](https://cosdna.com).
- Зверніть особливу увагу на тональний засіб, крем і сонцезахист — вони перебувають на шкірі найдовше.
- Шукайте маркування: «non-comedogenic», «oil-free», «для схильної до акне шкіри».

2.2 hair_products_acne — Засоби для волосся як тригер

Питання: «Чи помічаєте ви висипання вздовж лінії росту волосся або на лобі після використання засобів для волосся?»

ТАК

Акне від засобів для волосся (pomade acne) — поширена проблема, особливо на лобі та скронях.

- Замініть засоби для укладки: уникайте воску, помад, масел у прикореневій зоні.
- При нанесенні кондиціонера чи маски — відхиляйтеся від лінії росту волосся.
- Мийте волосся перед обличчям, а не після — щоб залишки засобів не потрапляли на шкіру.
- Обирайте засоби без силіконів, вазеліну та мінеральних олій у складі.
- Після тренування або на ніч — не залишайте нанесені стайлінг-засоби на шкірі обличчя.

НІ

Засоби для волосся не провокують висипання. Хороший знак!

- Продовжуйте поточну практику використання засобів для волосся.

НЕ ЗНАЮ

Поспостерігайте: чи з'являються висипання на лобі або скронях через 1–2 дні після нанесення нових засобів для волосся.

- Якщо так — це помадне акне. Скоротіть кількість засобів для укладки або замініть їх.

БЛОК 3. Спосіб життя

3.1 stress_worsens — Стрес погіршує акне

Питання: «Чи помічаєте ви, що висипання посилюються у стресові періоди?»

ТАК

Зв'язок стресу та акне науково підтверджений: кортизол підвищує секрецію себуму та провокує запалення.

- Щоденно практикуйте техніки зниження стресу: медитація, дихальні вправи, прогулянки.
- Метод дихання 4-7-8: вдих 4 сек, затримка 7 сек, видих 8 сек — 4 цикли, 2 рази на день.
- Регулярні фізичні навантаження (3–4 рази на тиждень) знижують кортизол.
- Адаптогени: ашваганда (300–500 мг), родіола — проконсультуйтеся з лікарем перед прийомом.
- За можливості — психотерапія або когнітивно-поведінкова терапія для управління хронічним стресом.

НІ

Стрес не є вашим основним тригером.

- Продовжуйте підтримувати психологічний баланс — це важливо для загального здоров'я.

ІНКОЛИ

Ситуативний стрес впливає на стан шкіри. Це нормально — але варто мати «план Б».

- У стресові тижні — посильте догляд: частіше використовуйте заспокійливі маски, знизьте кількість активних кислот.
- Дотримуйтеся технік релаксації хоча б у гострі стресові періоди.

3.2 sleep_quality — Якість сну

Питання: «Чи спите ви достатньо та добре висипаєтесь?»

ТАК

Якісний сон — основа регенерації шкіри.

- Підтримуйте режим: лягайте та прокидайтесь в один і той же час, навіть у вихідні.
- Замінюйте наволочку 2–3 рази на тиждень.

НІ

Поганий сон підвищує рівень кортизолу та інтерлейкіну-1 β , які безпосередньо посилюють запальне акне.

- Встановіть стабільний час відходу до сну — не пізніше 23:00.
- Прибрати екрани за 60 хвилин до сну або використовувати фільтр синього світла.
- Темна, прохолодна (18–20°C), тиха кімната — оптимальні умови для сну.
- Мелатонін (0.5–3 мг) за 30 хвилин до сну — при порушеннях режиму (короткострокове застосування).
- При хронічному безсонні — зверніться до лікаря або психолога, що практикує КПТ для сну.

ІНКОЛИ

Нестабільний сон — помірний тригер. Варто попрацювати над гігієною сну.

- Визначте дні з найгіршим сном — чи є зв'язок із наступними висипаннями?

- Стабілізуйте ранковий підйом — це найефективніший якір для циркадного ритму.

3.3 smoking — Куріння

Питання: «Ви курите?»

ТАК

Куріння суттєво погіршує акне: нікотин звужує судини, знижує кисень у шкірі та підвищує продукцію себуму. Також куріння уповільнює загоєння та посилює постакне.

- Відмова від куріння — один із найпотужніших кроків для покращення стану шкіри.
- Антиоксидантна підтримка: вітамін С (500 мг/добу) та вітамін Е нейтралізують вільні радикали від диму.
- Сироватка з вітаміном С 10–15% (накожно) допоможе покращити тон та регенерацію шкіри.
- Зверніться до програм відмови від куріння — лікар може призначити замісну терапію.

НІ

Чудово! Куріння не є вашим тригером.

- Також уникайте пасивного куріння — воно має схожий, але менш виражений ефект на шкіру.

ІНКОЛИ

Навіть ситуативне куріння впливає на мікроциркуляцію та запалення.

- Спробуйте повністю відмовитися або різко скоротити — шкіра відреагує позитивно вже за 4–6 тижнів.

3.4 water_intake — Споживання води

Питання: «Чи п'єте ви достатньо води щодня?»

ТАК

Гарна звичка! Достатнє зволоження підтримує бар'єрну функцію шкіри та прискорює виведення токсинів.

- Продовжуйте дотримуватись формули: $\text{маса тіла} \times 30\text{--}35 \text{ мл} = \text{добова норма}$.
- Пам'ятайте: кава, алкоголь і солодкі напої не зараховуються — вони діють як діуретики.

НІ

Зневоднення — недооцінений тригер акне. Шкіра відповідає на нестачу вологи підвищеним виробленням себуму.

- Розрахуйте вашу норму: $\text{маса тіла (кг)} \times 30\text{--}35 \text{ мл}$.
- Поставте нагадування на телефоні кожні 1.5–2 години.
- Почніть із додавання 2 склянок на день — поступово збільшуйте обсяг.
- Трав'яні чаї без цукру зараховуються до денної норми.

**НЕ
ЗНАЮ**

Варто почати відстежувати споживання рідини.

- Використайте мобільний додаток (WaterMinder, Hydro Coach) для трекінгу.
- Якщо сеча темно-жовта — ви п'єте недостатньо. Цільовий колір: блідо-жовтий.

БЛОК 4. Харчування

4.1 dairy_consumption — Молочні продукти

Питання: «Як часто ви споживаєте молочні продукти?»

РІДКО

Мінімальне споживання молочних продуктів знижує ризик молочно-індукованого акне.

	• Продовжуйте дотримуватись поточного підходу. • Якщо вживаєте молочне — обирайте ферментовані форми (йогурт, кефір): вони менш комедогенні.
--	---

ІНКОЛИ	Помірне споживання молочних продуктів може бути тригером акне (особливо знежирене молоко — воно містить більше гормонів IGF-1). • Спробуйте виключити молочне на 4 тижні та поспостерігайте за станом шкіри. • Альтернативи: вівсяне, мигдальне або кокосове молоко. • Найнейтральніші молочні продукти: тверді сири, масло (мало сироваткового протеїну).
---------------	---

ЧАСТО	Часте споживання молочних продуктів — один із доказово підтверджених тригерів акне. Молоко містить IGF-1, андрогени та гормони росту, які стимулюють себоцити. • Рекомендуємо 4-тижневий елімінаційний протокол: повністю виключити молочне. • Замініть: рослинні напої, тофу, бобові — джерела кальцію без гормонального навантаження. • Кальцій із продуктів: кунжут, брокколі, мигдаль, сардини (з кістками). • Після 4 тижнів — поступово повертайте по одному продукту і відстежуйте реакцію шкіри.
--------------	--

4.2 high_gi_diet — Продукти з високим глікемічним індексом

Питання: «Як часто ви вживаєте продукти з високим глікемічним індексом (білий хліб, солодке, фастфуд, газовані напої)?»

РІДКО	Низькоглікемічна дієта — наукова основа антиакне-харчування.
--------------	--

	• Продовжуйте надавати перевагу цільнозерновим продуктам, бобовим, овочам. • Такий підхід знижує рівень інсуліну та ІФР-1, що прямо зменшує активність сальних залоз.
ІНКОЛИ	Помірне споживання висококалорійних продуктів може впливати на рівень інсуліну та провокувати акне. • Намагайтесь замінити: білий рис → бурий, білий хліб → цільнозерновий, солодке → фрукти з низьким ГІ. • Поєднуйте вуглеводи з білком та клітковиною для зниження глікемічного відгуку.
ЧАСТО	Висококалорійна та висококалорійна їжа — один із провідних дієтичних тригерів акне. Різкі стрибки інсуліну активують андрогени та посилюють себорею. • Перейдіть на низькоглікемічну дієту (ГІ < 55): повільні вуглеводи, більше клітковини. • УНИКАЙТЕ: білий хліб, солодощі, фастфуд, газовані напої, картопля фрі, кукурудзяні пластівці. • ОБИРАЙТЕ: вівсянка, кіноа, гречка, бобові, некрохмалисті овочі, ягоди. • Омега-3 (1–2 г/добу з рибацького жиру або льняної олії) — протизапальна дія. • Цинк (25–40 мг/добу) — зменшує виробництво себуму. Продукти: гарбузове насіння, устриці, яловичина. • Антиоксиданти: зелений чай (EGCG), куркума — включіть у раціон.

4.3 food_triggers — Харчові тригери

Питання: «Чи помічаєте ви, що певні продукти провокують висипання?»

ТАК	Індивідуальна чутливість до продуктів — важливий і часто ігнорований фактор. • Ведіть харчовий щоденник: записуйте, що їли та стан шкіри через 48–72 год. • Найпоширеніші тригери: шоколад (молочний), горіхи (особливо арахіс), алкоголь, гострі продукти. • Елімінаційний протокол: виключайте підозрюваний продукт на 3–4 тижні, потім повертайте. • Після виявлення тригерів — не обов'язково виключати повністю, можливо достатньо обмежити.
НІ	Харчових тригерів не виявлено. Продовжуйте збалансоване харчування. • Сфокусуйтеся на загальних принципах: менше цукру, більше овочів та омега-3.
НЕ ПОМІЧАВ	Ви, можливо, не відстежували зв'язок між їжею та станом шкіри. • Спробуйте 2–4 тижні вести харчовий щоденник — це часто відкриває неочевидні закономірності. • Фотографуйте шкіру щоранку для об'єктивного порівняння.

БЛОК 5. Стан шкіри

5.1 skin_type — Тип шкіри

Питання: «Який тип шкіри у вас?»

ЖИРНА	Жирна шкіра має розширені пори та підвищену себорею — основний ризик акне.
--------------	---

	• Очищення: гель із саліциловою (2%) або гліколевою кислотою 2 рази на день. • НЕ пересушуйте шкіру — зневоднений епідерміс виробляє ще більше себуму. • Зволоження: легкий гель на основі гіалуронової кислоти або ніацинаміду. • Матуючі продукти: з каоліном або крохмалем — для денного контролю блиску. • Ретинол — ключовий інгредієнт для регуляції роботи сальних залоз.
--	--

КОМБІНОВАНА	Комбінована шкіра: Т-зона жирна, щоки нормальні або сухі. • Догляд по зонах: для Т-зони — матуючі засоби, для щік — зволожуючі. • Обирайте некомедогенні продукти з легкою текстурою для всього обличчя. • Маски застосовуйте лише на проблемні зони, не на все обличчя.
--------------------	---

НОРМАЛЬНА	Нормальна шкіра — найлегший тип у догляді. • Підтримуйте бар'єрну функцію: м'яке очищення + зволоження + SPF. • Акне при нормальній шкірі часто пов'язане з гормонами або зовнішніми тригерами.
------------------	---

СУХА	Суха шкіра + акне — нетипова комбінація, часто пов'язана з гормонами або неправильним доглядом. • Уникайте пересушуючих засобів: без ацетону, жорстких ПАР. • Активні кислоти вводьте обережно та зрідка. • Інтенсивне зволоження обов'язкове: керамідні креми, ліпідні відновлювальні засоби.
-------------	---

	• Розгляньте консультацію дерматолога — поєднання сухої шкіри та акне може вимагати специфічного підходу.
--	---

НЕ ЗНАЮ	Визначте тип шкіри протягом 1 години після очищення (без нанесення засобів): • Блищить всюди → жирна • Блищить тільки в Т-зоні → комбінована • Ані блиску, ані стягування → нормальна • Відчуття стягування, лущення → суха
----------------	---

5.2 oily_skin_hair — Жирність шкіри та волосся

Питання: «Чи є у вас підвищена жирність шкіри або швидко забруднюється волосся?»

ТАК	Підвищена жирність може вказувати на гіперандрогенію або підвищений рівень ДГТ. • Засоби для догляду з ніацинамідом (5–10%) — регулюють себум. • Цинк пірітіон у шампунях — для жирного волосся та шкіри голови. • При поєднанні жирного волосся + акне на лінії росту волосся — перевірте на демодекоз. • Якщо жирність різко посилилась — зверніться до ендокринолога для аналізу на андрогени.
------------	---

НІ	Жирність у нормі. Продовжуйте поточний догляд.
-----------	--

ІНКОЛИ	Ситуативна жирність (стрес, жара, менструальний цикл) — нормальне явище. • Носіть матуючі серветки для контролю блиску протягом дня.
---------------	---

- Відстежте, у які дні жирність посилюється — чи є зв'язок із циклом або стресом?

5.3 jawline_acne — Акне на підборідді та щелепній лінії

Питання: «Чи з'являються у вас висипання переважно на підборідді та вздовж щелепної лінії?»

ТАК

Локалізація на підборідді та щелепній лінії — класична ознака гормонального акне.

- Зверніться до гінеколога-ендокринолога або ендокринолога: аналізи на LH, FSH, тестостерон, ДГЕА-С, пролактин.
- Для жінок: розгляньте гормональну терапію (КОК) — за призначенням лікаря.
- Місцево: адапален або азелаїнова кислота на підборіддя.
- Уникайте руки на підборідді (механічне акне від тиску та бактерій).
- Спростіть стайлінг на підборідді — засоби для укладки волосся можуть потрапляти на цю зону.

НІ

Акне не локалізоване в гормональній зоні. Це добрий знак щодо гормонального балансу.

- Аналізуйте інші можливі тригери: косметика, харчування, стрес.

НЕ ЗНАЮ

Поспостерігайте за локалізацією висипань.

- Якщо більшість елементів на підборідді та щелепній лінії — це вказує на гормональне акне.

5.4 demodex_suspicion — Підозра на демодекоз

Питання: «Чи підозрюєте ви у себе демодекоз (кліщ Demodex)?»

ТАК

Демодекоз — інфекція кліщем *Demodex folliculorum*, що живе у волосяних фолікулах. Симптоми: свербіж (особливо вночі), відчуття «повзання», запалення навколо носа та щік, стійке до звичайного лікування акне.

- **ОБОВ'ЯЗКОВО:** підтвердити діагноз у дерматолога — мікроскопія (соскрібок).
- Лікування призначає лікар: метронідазол гель/крем, івермектин крем (Soolantra), пероральний метронідазол.
- Засоби з чайним деревом (Tea Tree Oil 5%) — має активність проти *Demodex* (допоміжна терапія).
- Гігієна: замінюйте наволочку щодня, не використовуйте рушники для обличчя більше одного разу.
- Уникайте жирних кремів та олій на ніч — вони створюють ідеальне середовище для розмноження кліща.

НІ

Демодекоз не підозрюється. Продовжуйте стандартний догляд.

- Гігієна залишається важливою: чисті рушники, регулярна зміна наволочки.

НЕ ЗНАЮ

Ознаки можливого демодекозу: свербіж шкіри ввечері та вночі, відчуття поколювання, висипання, що не реагують на стандартне лікування акне.

- Якщо є ці симптоми — зверніться до дерматолога для соскрібку.
- Профілактика: регулярно міняйте наволочку, мийте пензлі для макіяжу щотижня.

5.5 vitamin_d_deficiency — Дефіцит вітаміну D

Питання: «Чи є у вас підтверджений або підозрюваний дефіцит вітаміну D?»

ТАК

Дефіцит вітаміну D пов'язаний із посиленням запальних процесів у шкірі та імуносупресією. Норма у крові: 30–100 нг/мл (75–250 нмоль/л). Дефіцит: < 20 нг/мл.

- Зверніться до лікаря для призначення коректної дози (часто 2000–5000 МО на добу залежно від рівня).
- За відсутності можливості — можна розпочати із 2000 МО/добу вітаміну D3 (холекальциферол) у формі масляних крапель або капсул. Курс: 3 місяці, потім повторити аналіз.
- Приймайте разом із вітаміном K2 (МК-7, 100 мкг) та з їжею, що містить жири — для кращого засвоєння.
- Їжа, що підвищує вітамін D: жирна риба (оселедець, скумбрія, лосось), яєчний жовток, печінка тріски, гриби (особливо опромінені UV), збагачені молочні продукти.
- Перебування на сонці: 15–30 хвилин на день (руки та обличчя, з 10:00 до 15:00, без SPF).

НІ

Чудово! Рівень вітаміну D у нормі. Це важливо для здоров'я шкіри та імунітету.

- Щоб підтримувати хороший рівень: регулярні прогулянки на сонці 15–20 хв/день.
- У зимові місяці або при мінімальному перебуванні на сонці — профілактична доза 800–1000 МО/добу.
- Включайте у раціон: жирна риба 2–3 рази на тиждень, яєчний жовток, гриби.
- Повторюйте аналіз раз на рік — рівень D може знижуватися взимку.

**НЕ
ЗНАЮ**

Варто перевірити! Дефіцит вітаміну D дуже поширений (за різними даними, до 70–80% населення України мають недостатність).

- Здайте аналіз: 25(OH)D у сироватці крові — простий аналіз, доступний у будь-якій лабораторії.
- Чому це важливо: вітамін D регулює імунну відповідь, зменшує запалення та впливає на вироблення антимікробних пептидів у шкірі.
- Без аналізу можна розпочати із профілактичної дози 1000–2000 МО/добу D3 — загалом безпечно для більшості дорослих.
- Їжа для підтримки: жирна риба, яєчний жовток, гриби UV, збагачені продукти.
- Сонце: 15–30 хв на відкритому повітрі щодня (без SPF на тілі у безпечні години).

5.6 dairy_gi_issues — Чутливість до молочних продуктів

Питання: «Чи є у вас проблеми з травленням при вживанні молочних продуктів (здуття, дискомфорт)?»

ТАК

Лактазна недостатність або непереносимість молочного білка (казеїну) — виключіть молочне для покращення як травлення, так і стану шкіри.

- Повністю виключіть молочні продукти щонайменше на 4–6 тижнів.
- Замініть на: рослинні напої (вівсяне, мигдальне, кокосове молоко без цукру).
- Кальцій із рослинних джерел: кунжут, кейл, брокколі, бобові, мигдаль, тофу.
- Можливо, ферментовані форми (кефір, йогурт) переносяться краще — лактоза частково розщеплена.
- Ферменти лактази (добавка) допомагають при лактазній недостатності.

НІ

Травних проблем від молочного немає. Молочні продукти переносяться добре.

- Попри відсутність ГІ-симптомів, молочне все одно може впливати на акне через IGF-1 та гормони.
- При стійкому акне — спробуйте 4-тижневе виключення молочного для аналізу впливу.

НЕ ЗНАЮ

Поспостерігайте за самопочуттям після вживання молочних продуктів протягом 2 годин.

- Симптоми лактазної недостатності: здуття, газоутворення, діарея або дискомфорт у животі.
- Можна провести домашній тест: виключити молочне на 2 тижні, потім повернути у великій кількості — якщо є дискомфорт, підтверджується чутливість.